

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN DIGESTIVO

GASTROSCOPIA

Raisa Quiñones Castro, Carmen Villar Lucas, Pedro Linares Torres.

Qué es

La endoscopia digestiva alta es una técnica que permite mediante la utilización de un gastroscopio la visualización de esófago, estómago y duodeno con intención diagnóstica y también terapéutica en caso necesario.

Procedimiento

El gastroscopio es un tubo flexible que posee un canal con una cámara con luz que permite visualizar el interior del tubo digestivo e introducir a través de él material para realizar terapéutica. Para ello se coloca al paciente en decúbito lateral con la cabeza un poco elevada con una almohada y se introduce el endoscopio en la boca a través de un mordedor.

Previamente a la realización de esta prueba el paciente debe ser debidamente informado del procedimiento, la indicación y las posibles complicaciones, firmando un consentimiento informado por escrito. Según la indicación y el entorno, la gastroscopia se puede realizar únicamente con anestesia tópica en la orofaringe o con una sedación superficial controlada por gastroenterólogo o anestesista, con monitorización de constantes. Consideraciones previas:

- Se recomienda periodo de ayunas de al menos 6 horas (a excepción de los casos urgentes).
- Interrogar sobre alergias y antecedentes personales
- No se recomienda profilaxis antibiótica
- Revisar la medicación habitual del paciente, especialmente anticoagulantes y antiagregantes

ANEXO 1: MANEJO DE LOS ANTICOAGULANTES Y ANTIAGREGANTES EN ENDOSCOPIA.

FÁRMACOS	TIEMPO
SINTROM	SUSPENDER 5 DÍAS ANTES Y PASE A HBPM
NUEVOS ACO	SUSPENDER 48 HORAS ANTES
ADIRO 100	NO ES NECESARIO SUSPENDER
ADIRO 300	ENTRE 5 Y 7 DÍAS ANTES, PASE A ADIRO 100
OTROS ANTIAGREGANTES	7 DÍAS ANTES Y PASE A ADIRO 100.

*Valorar en conjunto con MAP, cardiología y hematología, en situaciones de alto riesgo cardiovascular (implante stent reciente, TVP...). En ciertos casos puede ser necesario retrasar la endoscopia hasta que sea posible el ajuste de tratamiento

La duración de la exploración será de entre 5 y 30 minutos y dependerá de diferentes factores, principalmente de si es necesario realizar terapéutica o no.

Indicaciones

Persistencia de síntomas digestivos altos a pesar de terapia apropiada
 Síntomas digestivos altos asociados con signos o síntomas sugestivos de enfermedad orgánica (anorexia, pérdida de peso...) o de nueva aparición en >50 años
 Disfagia u odinofagia
 Síntomas de reflujo gastroesofágico refractarios a tratamiento
 Vómitos persistentes de causa desconocida
 Síndromes de poliposis familiar
 Hemorragia gastrointestinal: Sangrado activo o reciente, o sospecha de sangrado (pérdidas crónicas, anemia ferropénica)
 Seguimiento de lesiones premalignas, como el esófago de Barrett
 Tratamiento hemostático de lesiones sangrantes, como úlceras, tumores, lesiones vasculares...

Extracción de cuerpos extraños
 Resección de pólipos
 Dilatación de estenosis
 Colocación de gastrostomía percutánea
 Tratamiento de la acalasia (inyección de toxina botulínica, dilatación con balón...)
 Tratamiento paliativo de neoplasias (colocación de stents...)
 Diagnóstico y/o tratamiento de varices esofágicas/esofagogástricas
 Evaluación del daño mucoso tras ingesta cáustica
 Confirmación y diagnóstico histológico de lesiones diagnosticadas en prueba de imagen: lesiones sospechosas de malignidad, úlceras, estenosis u obstrucción del tracto digestivo alto

Contraindicaciones

- Sospecha de perforación visceral
- Siempre que los riesgos superen a los posibles beneficios

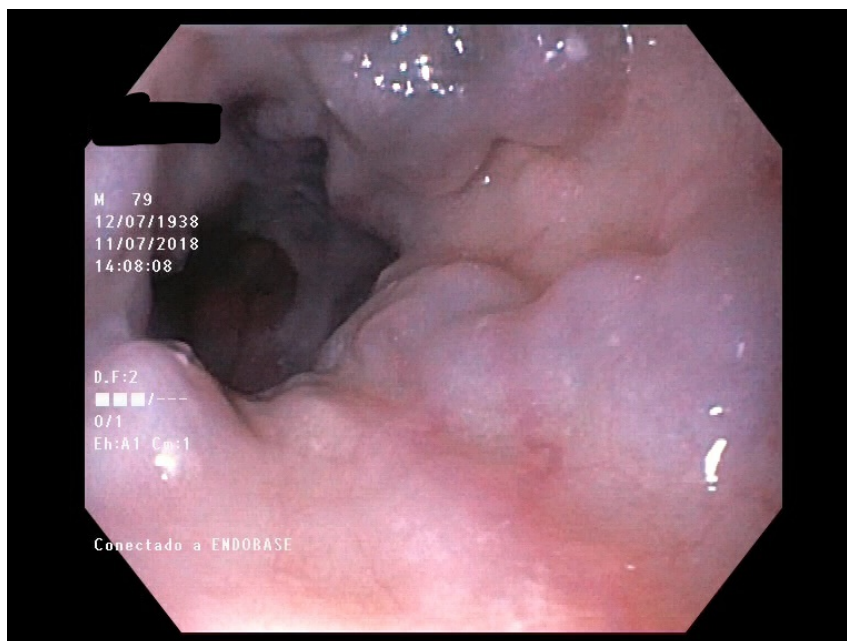
Complicaciones

La gastroscopia es un procedimiento seguro, siendo muy infrecuentes las complicaciones. La perforación ocurre en el 0,05-0,7% de los casos. El 60% de los efectos adversos son de tipo cardiopulmonar y son más frecuentes en procedimientos con sedación.

- Perforación
- Sangrado secundario a trauma o biopsia
- Infección
- Complicaciones cardiopulmonares (broncoaspiración)
- Interpretación inadecuada



Úlcus duodenal



Varices esofágicas grado III

Gastrostomía endoscópica percutánea

La gastrostomía consiste en la inserción de una sonda de nutrición enteral a través de la pared abdominal, realizando una comunicación directa con el estómago. En la actualidad la mayoría se realizan guiadas por radiología (GIR) o mediante endoscopia alta (PEG). El primer recambio debe realizarse en entorno hospitalario con el mismo método a los 2-3 meses de su inserción, cambiándose por una sonda con balón. Esta sonda tiene la ventaja de que se puede recambiar de forma ambulatoria por médicos generales e incluso enfermería.

Indicaciones de realizar recambio: deterioro de la sonda o el estoma, rotura del balón, pérdida o arrancamiento de la sonda. Con una buena higiene pueden tener una duración de 6-8 meses

Es muy importante en caso de pérdida de la sonda evitar el cierre de la ostomía, colocando de forma lo más temprana posible una sonda Foley o similar en su lugar

Procedimiento de recambio:

- Desinfectar la zona del estoma
- Comprobar el correcto funcionamiento del globo y la permeabilidad de la sonda en el exterior
- Deshinchar el globo, lubricar la sonda e introducirla por el estoma.
- Hinchar el globo con 20cc de suero y realizar tracción



Referencias

- Cécil Essentials of medicine. Chapter: Endoscopic and Imaging procedures (Chistopher S. Huang, M. Michael Wolfe)
- American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE): Appropriate use of gastrointestinal endoscopy. Gastrointestinal Endoscopy, 2012;75: 1127-1131
- Phenninger and Fowler's procedures for primary care. Chapter 101. 699-714. Edward G. Zurad

COLONOSCOPIA

Carmen Villar Lucas, Raisa Quiñones Castro, Agustín Herrera Abián.

Qué es

La colonoscopia es una técnica que permite la visualización directa de la mucosa del colon, desde recto hasta íleon terminal, permitiendo realizar diagnóstico y terapéutica. En ocasiones se realiza solo rectosigmoidoscopia, explorándose solo estos segmentos intestinales.

Procedimiento

El colonoscopio es un tubo flexible de 170 cm que se introduce por el recto y que consta de una óptica, una luz y un canal de trabajo.

Preparación: Para que sea posible una correcta visualización de la mucosa intestinal es imprescindible que la limpieza sea adecuada, por lo que el paciente deberá realizar una buena preparación del colon.

Dieta líquida los 2-3 días antes (varía según centros hospitalarios)

Soluciones con polietilenglicol (Solución evacuante Bohn®): 8 litros divididos en dos dosis: el día antes y 4 horas antes de la prueba. Si la colonoscopia es por la mañana: 12 sobre en 3 litros de agua, se comienza a beber la tarde antes de la prueba, y 4 sobres en 1 litro 4 horas antes de la prueba. Si la prueba se realiza por la tarde, empezar a tomar toda la preparación 8 horas antes de la prueba.

Productos basados en el picosulfato sódico (Citrafleet®): esta preparación se realiza en dos tomas que se adaptan a la hora de su colonoscopia. Cada toma consiste en beber un sobre de

Citrafleet® disuelto en un vaso de agua, teniendo que tomar a continuación al menos 2 litros de los líquidos claros permitidos). En caso de estreñimiento, antes de cada toma se recomienda ingerir 2 comprimidos de Bisacodilo (Dulcolaxo®). - Si la exploración se realiza por la mañana: la Toma 1 se realiza a las 17 horas (5 p.m.) y la Toma 2 a las 23:30 horas (11:30 p.m.) del día anterior a la prueba. - Si se realiza por la tarde: la Toma 1 se realiza a las 20 horas (8 p.m.) del día anterior a la prueba y la Toma 2 a las 10 horas (10:00 a.m.) del mismo día de la endoscopia.

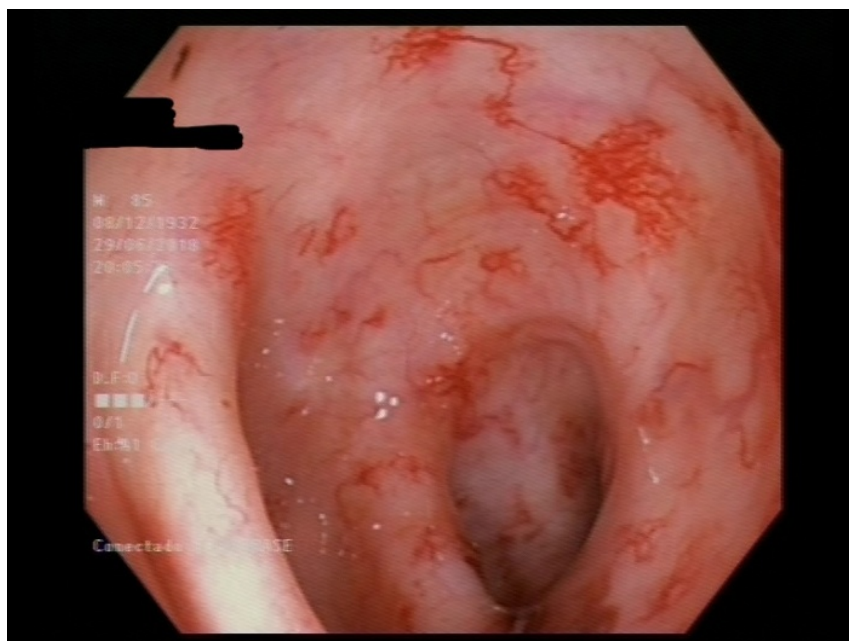
Productos basados en el macrogol o de bajo volumen (Moviprep®): esta preparación se realiza en dos tomas que se adaptan a la hora de su colonoscopia. Cada toma consiste en mezclar el contenido de un sobre A y un sobre B en un litro de agua que se debe beber a lo largo de 1-2 horas, intentando tomar un vaso completo al menos cada 15 minutos. Posteriormente debe beber al menos 1 litro de los líquidos claros permitidos. Si la exploración se realiza por la mañana: la Toma 1 se realiza a las 17 horas (5 p.m.) y la Toma 2 a las 23:30 horas (11:30 p.m.) del día anterior a la prueba. Si se realiza por la tarde: la Toma 1 se realiza a las 20 horas (8 p.m.) del día anterior a la prueba y la Toma 2 a las 10 horas (10:00 a.m.) del mismo día de la endoscopia.

El médico prescriptor de la prueba deberá tener en cuenta que pacientes con situaciones especiales como insuficiencia renal o cardíaca pueden requerir ajuste de esta preparación.

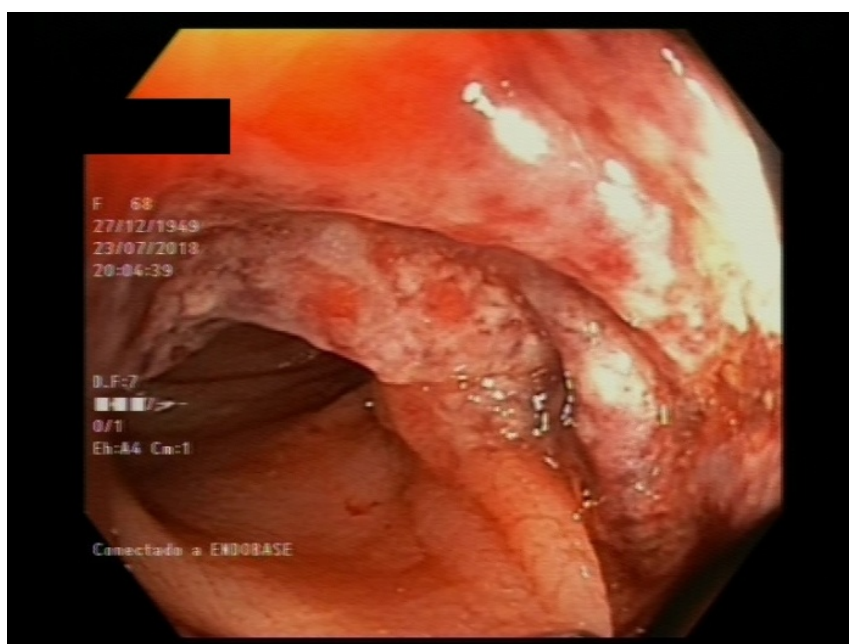
Previamente a la realización de esta prueba el paciente debe ser debidamente informado del procedimiento, la indicación y las posibles complicaciones, firmando un consentimiento informado por escrito. Se deberá tener precaución con el uso de antiagregantes y anticoagulantes (ver tabla en el capítulo de Gastroscoopia)

Actualmente la mayoría de las colonoscopias se realizan con sedación, por lo que se recomienda acudir con un acompañante y evitar conducir o beber alcohol tras la prueba.

Indicaciones	Contraindicaciones
Hemorragia digestiva baja Diarrea crónica Sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal Seguimiento para diagnóstico precoz de cáncer de colon en enfermedad inflamatoria intestinal y síndromes de poliposis familiar Terapéutica: extirpación de pólipos, extracción de cuerpo extraño, descompresión de vólvulo de colon o megacolon tóxico, hemostasia (clip, cauterización...), cecostomía percutánea, dilatación de estenosis, colocación de prótesis...	Perforación colónica Peritonitis Fallo cardiorrespiratorio agudo IAM reciente Cirugía colónica reciente Aneurisma abdominal de gran tamaño o en sus ramas Diverticulitis (relativa)



Proctitis actínica



Colitis isquémica

Complicaciones

- Perforación colónica (más frecuente si se realiza terapéutica, si existe diverticulosis severa...)
- Bacteriemia (por ello los pacientes con alto riesgo de endocarditis requieren profilaxis)
- Dolor abdominal por exceso de insuflación
- Hemorragia postpolipectomía (asociada al tamaño del pólipo y el uso de antiagregantes y anticoagulantes)
- Síndrome postpolipectomía (dolor y fiebre sin perforación)

BIBLIOGRAFÍA

- Gastrointestinal endoscopy in practise. Chapter: Diagnostic colonoscopy. Jean Mark Canard, Jean-Christophe Létard, Ian Penman

- Phenninger and Fowler's procedures for primary care. Chapter 100. 685-689. John Bartels Pope
- Documento de consentimiento informado para colonoscopia de la UED del Hospital Universitario de La Princesa. Revisado: Dr. J.A. Moreno Monteagudo Responsable de la UED y Responsable de Calidad Dr. C. Santander Vaquero Jefe de Servicio de Aparato Digestivo